

Hipoteza *terapeutyczna*

Robocze sformułowanie *terapeuty*: jakie przekonanie, skąd, jak się utrzymuje, kiedy się aktywuje, jakie techniki. Nie diagnoza — hipoteza empiryczna otwarta na rewizję.

CZAS: 30 min · poziom zaawansowany Pierwsza wersja po 2–3 sesjach; aktualizacja co 5–10

ŹRÓDŁO: Persons (2008)

JAK UŻYWAĆ

Formalizujesz własne rozumowanie kliniczne w pięciu pytaniach: jakie jest przekonanie kluczowe, jak się uformowało, jak się utrzymuje, kiedy się aktywuje, jakie techniki będą najskuteczniejsze. To narzędzie **przede wszystkim dla terapeuty**, dzielone z klientem w uproszczonej formie. Trzymasz 2–3 alternatywne hipotezy, każdą z dowodami za, i aktualizujesz wraz z nowymi danymi.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Sztywna, broniona hipoteza prowadzi do ignorowania piętrzących się dowodów; brak hipotezy — do reagowania sesja po sesji bez kierunku. Hipoteza robocza (ang. *working hypothesis*) jest narzędziem współpracy empirycznej: terapeuta i klient są współpracownikami-badaczami. Musi być **falsyfikowalna**: jeśli po 4–5 sesjach pracy z przekonaniem nie ma zmiany, nie zwiększaj „dawki” tej samej techniki — zmodyfikuj hipotezę. Może przekonanie jest inne, może aktywują się niezidentyfikowane strategie kompensacyjne. Superwizja, w której kolega kwestionuje hipotezę, jest tu kluczowa.

01



Pięć pytań roboczych

1 · JAKIE PRZEKONANIE KLUCZOWE

2 · JAK SIĘ UFORMOWAŁO

3 · JAK SIĘ UTRZYMUJE

4 · KIEDY SIĘ AKTYWUJE

5 · JAKIE TECHNIKI BĘDĄ NAJSKUTECZNIEJSZE

02 Dwie–trzy alternatywy

Zapisz konkurencyjne hipotezy o rdzeniu, każdą z dowodami za. To chroni przed przedwczesnym zamknięciem.

HIPOTEZA A + DOWODY

HIPOTEZA B + DOWODY

03 Test falsyfikacji

Co by przemawiało *przeciw* Twojej głównej hipotezie? Jeśli takie dane się pojawią — modyfikuj hipotezę, nie wymuszaj danych.

CO FALSYFIKOWAŁOBY MOJĄ HIPOTEZĘ

04 Rewizja i superwizja

Zaplanuj aktualizację co 5–10 sesji i przynieś hipotezę na superwizję, by kolega ją zakwestionował.

CO SPRAWDZIĆ PRZY NASTĘPNEJ REWIZJI

Klucz: hipoteza musi być kwestionowana. Jeśli po 4–5 sesjach pracy z przekonaniem nie ma zmiany — nie zwiększaj „dawki” tej samej techniki, lecz zmodyfikuj hipotezę. Otwartość na rewizję odróżnia dobrą terapię poznawczo-behawioralną od aplikowania protokołu.